

 SCHINDLER INTENSIVPFLEGE WIRTSCHAFTS-UNIVERSITÄT WIEN	Notfallstandard Verdacht auf Unterzuckerung	Qualitätshandbuch
		Geltungsbereich: Pflegefachkraft

Definition:

Blutzucker liegt unter 50 mg/dl

1. Ziel:

- Die Mitarbeiter der Pflege sind in der Lage, unverzüglich, gezielt, sicher und umsichtig zu handeln

2. Anwendungsbereich:

Bewohner ist ansprechbar:

Symptome:

- Zittern
- Schweißausbruch
- Heißhunger
- Herzklopfen/-rasen
- Unruhe
- Nervosität
- Sprachstörungen
- Krämpfe
- Herausforderndes Verhalten

Bewohner ist nicht mehr ansprechbar:

Symptome:

- Bewohner ist kaltschweißig
- Blasses Gesicht
- Kalte Hände
- Schocksymptome
- Krämpfe

3. Durchführung und Zuständigkeiten:

Bewohner ist ansprechbar:

- Bei Gefahr von Kontamination mit Blut oder anderen Körperflüssigkeiten oder Körperausscheidungen sind Handschuhe zu tragen
- Blutzucker bestimmen, Vitalwerte messen
- Traubenzucker geben (3 Esslöffel Traubenzucker gelöst in Flüssigkeit)
- Pflegekraft bleibt beim Bewohner
- Information an den Hausarzt/ Notarzt (**Rufnummer 0-112**)
- Es wird mit der Rettungsleitstelle vereinbart, dass ein Mitarbeiter des Hauses die Rettungskräfte vom Haupteingang bis zum Zielpunkt begleitet
- Nach Eintreffen des Notarztes nach ärztlicher Anordnung handeln

Freigabe	Bearbeiter	Datum	Änderung	Version	Seite	Verteiler
GF	PDL/QMB	01.01.2024		1	1	Verw./MA

Zur besseren Lesbarkeit wird die männliche Form der Anrede genutzt. Selbstverständlich sind alle Geschlechter gemeint.

 SCHINDLER INTENSIVPFLEGE	Notfallstandard Verdacht auf Unterzuckerung	Qualitätshandbuch
		Geltungsbereich: Pflegefachkraft

- Bewusstseinslage des Bewohners beobachten
- Wenn der Blutzucker nach einer halben Stunde zwischen 80 und 120 mg/dl liegt, Info an den Hausarzt

Bewohner ist nicht mehr ansprechbar:

- Bewohner in die stabile Seitenlage bringen
- Blutzucker bestimmen, Vitalwerte messen
- Notarzt rufen (**Rufnummer 0-112**)
- Kollegen verständigen über Diensthandy oder lautes Rufen
- Es muss sichergestellt werden, dass die Rettungskräfte von einem Mitarbeiter des Hauses empfangen und eingewiesen werden
- Nach Eintreffen des Notarztes nach ärztlicher Anordnung handeln
- Die Krankenhauseinweisung wird gemäß Verfahrensanweisung vorbereitet
- Pflegekraft bleibt beim Bewohner, bis der Notarzt eintrifft
- Bewusstseinslage des Bewohners beobachten

Nachbereitung:

- Information an Angehörige/ Betreuer
- Information an den Hausarzt
- Nach einem Unfall wird der Inhalt des Notalkoffers überprüft und ggf. veranlassen, dass dieser von der Vertragsapothek e aufgefüllt wird
- Information an die Pflegedienstleitung/ stellvertretende PDL.
Wenn die Notsituation am Wochenende/ Feiertag eintritt, wird die Information am nächsten Werktag weitergegeben

Dokumentation:

- Bericht eblatt
- Ärztliche Kommunikation
- Vitalwerte – Blutzuckerprofil
- Ggf. Ärztliche Verordnung

Durchführungsverantwortlichkeit/Qualifikation:

- Alle Pflegekräfte

Prozessverantwortlichkeit:

- Pflegedienstleitung, QMB, stellvertretende PDL, Wohnbereichsleitung

Freigabe	Bearbeiter	Datum	Änderung	Version	Seite	Verteiler
GF	PDL/QMB	01.01.2024		1	2	Verw./MA

Zur besseren Lesbarkeit wird die männliche Form der Anrede genutzt. Selbstverständlich sind alle Geschlechter gemeint.